

Trabajo Práctico Nº 20: Envejecimiento Normal y Patológico

1. ¿Qué funciones cognitivas declinan con la edad en un envejecimiento normal y cuáles permanecen intactas?

En el **envejecimiento normal**, se observa una serie de modificaciones en las capacidades cognitivas, aunque **no existe un deterioro de la memoria que sugiera un proceso patológico**.

Las **principales funciones que típicamente declinan** o se modifican con la edad son:

- Enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información y del aprendizaje.
- Disminución de las capacidades de atención dividida.
- Dificultades para inhibir información irrelevante y respuestas inapropiadas, lo que se traduce en un aumento de la distractibilidad.
- Enlentecimiento en el acceso a la información.
- Disminución de la memoria de trabajo.

La dificultad en el acceso a la información puede manifestarse como **dificultad para recordar nombres de personas y lugares**, junto con el **aumento del fenómeno de tener una "palabra en la punta de la lengua"** sin lograr pronunciarla.

Las funciones cognitivas que **permanecen intactas** en el envejecimiento normal, a pesar de las quejas de memoria que puedan surgir, son aquellas que definen la ausencia de demencia o patología. En la **comprensión de órdenes** y las **capacidades aritméticas (cálculo)**, el adulto mayor normal no presenta dificultades (o solo enlentecimiento), a diferencia del trastorno de memoria patológico.

2. ¿Qué tipos de memoria se afectan en el envejecimiento y cuáles permanecen intactas?

Describir cada una.

En el **envejecimiento normal**, el deterioro de la memoria en sí mismo no existe, pero sí se ve afectada la **memoria de trabajo**. Esto puede manifestarse en la dificultad de **olvidar lo que se fue a buscar a alguna habitación** tan pronto se entra en ella, u **olvidar un número de teléfono** que se tiene que marcar si uno es interrumpido.

En el envejecimiento normal, la dificultad no reside en el almacenamiento, sino en el **acceso a la información** (como el fenómeno de la "palabra en la punta de la lengua"). El olvido en el adulto mayor normal es de **fragmentos o detalles de un evento** y es **ocasional**, en contraste con la patología.

3. ¿Por qué se afectan algunos tipos de memoria más que otras? ¿Cuándo debería consultar un paciente que tiene problemas de memoria?

Afectación diferencial de la memoria

La razón por la cual algunos tipos de memoria se afectan más que otros está intrínsecamente ligada a la **etiología** y la **distribución topográfica de las lesiones** en el cerebro, especialmente en las demencias neurodegenerativas.

En la Enfermedad de Alzheimer (EA) típica, el trastorno de memoria es el principal síntoma. Esto se debe a que existen depósitos de proteína Tau en **ovillos neurofibrilares intracitoplasmáticos** que se acumulan preferentemente en las **regiones hipocampales** y en las áreas asociativas posteriores (lóbulo parietal). La topografía de estas lesiones explica por qué predominan los trastornos de la **memoria episódica**.

En cambio, en los **síndromes fronto-subcorticales**, como la Parálisis Supranuclear Progresiva o la Enfermedad de Parkinson, puede observarse un **almacenamiento conservado** con **dificultades predominantes en la evocación**.

En las **Demencias Frontotemporales** de tipo conductual (DFT), predominan los trastornos de las **funciones ejecutivas**, y el trastorno de la memoria puede no ser el elemento cardinal.

¿Cuándo debería consultar un paciente que tiene problemas de memoria?

Se sospecha que un sujeto presenta un deterioro cognitivo que justifica una evaluación clínica cuando se observan los siguientes elementos, ya que **indican un proceso patológico**:

- El olvido es **de todo un evento o de la ocurrencia de un evento**, a diferencia del adulto mayor normal que olvida fragmentos o detalles.
- El olvido de palabras o nombres es de **intensidad progresiva** (no ocasional).
- Los olvidos atencionales (extravíos de objetos, olvido de una cita) **aumentan en frecuencia**.
- El **empeoramiento es progresivo** en severidad y frecuencia.
- El paciente tiene **dificultad de aprendizaje** incluso si se esfuerza.
- Hay **olvido de eventos vitales** o información importante para el paciente.
- **Repercusión en la vida diaria y comportamiento**:
 - El déficit cognitivo **interfiere con las actividades cotidianas** (manejo de dinero, pago de cuentas, toma de medicamentos, etc.).
 - **Dificultad progresiva en la comprensión de órdenes**.
 - **Incapacidad progresiva para seguir una película o leer un libro**.
 - El sujeto **minimiza sus dificultades**, las cuales son referidas por alguien de su entorno.
 - El paciente presenta **preguntas o cuentos repetitivos**.
 - Hay **confusión frente a imprevistos** o **dificultad para adaptarse a situaciones nuevas**.
 - Los olvidos se acompañan de **otros déficits**, como discalculia, fallas en la comprensión verbal o modificación de la personalidad.

4. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del Deterioro Cognitivo Leve (DCL) del National Institute on Aging & Alzheimer's Association? ¿Qué tipos de DCL existen?

El Deterioro Cognitivo Leve (DCL) fue acuñado por Petersen y colaboradores (1999) para referirse a los trastornos cognitivos adquiridos con **preservación de la funcionalidad**. El DCL constituye un estadio intermedio entre el envejecimiento normal y las demencias, preservando la autonomía para las actividades de la vida diaria.

Criterios relacionados del DSM-V:

El concepto de DCL en las fuentes es equiparable al **Trastorno Neurocognitivo Menor** del DSM-V, el cual requiere:

1. Evidencia de un declive cognitivo significativo en **uno o más dominios cognitivos**.
2. El declive se basa en la preocupación del individuo, de un informante o del clínico.
3. Hay un **deterioro sustancial del rendimiento cognitivo**, preferentemente documentado por un test neuropsicológico estandarizado o evaluación clínica cuantitativa.
4. Los déficits cognitivos **no interfieren con la independencia en las actividades cotidianas** (aunque puede requerir mayor esfuerzo o estrategias de compensación).
5. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un síndrome confusional.
6. Los déficits no se explican mejor por otros trastornos mentales (ej. trastorno depresivo mayor o esquizofrenia).

DCL Amnésico

- Queja y disminución objetiva de memoria.
- Preservación de las otras funciones cognitivas.
- **Puede progresar a:** Demencia tipo Alzheimer.

DCL de Múltiple Dominio

- Presencia de una **leve disminución en más de una capacidad cognitiva**.
- **Puede progresar a:** Demencia tipo Alzheimer, Demencia Vascular.

DCL de Un Dominio (no memoria)

- **Presencia de una disminución objetiva en:** Lenguaje, función Viso-Espacial o Función Ejecutiva.
- **Puede progresar a:** Demencia Fronto-temporal, Demencia por cuerpos de Lewy, Afasia progresiva primaria, Demencia Vascular.

5. ¿Cuáles son las características de un test de screening? ¿Cuáles existen?

Características de un buen Test de Screening Cognitivo

Un test de screening cognitivo es una **evaluación breve** que proporciona un panorama general de las funciones cognitivas de un paciente en un corto período de tiempo. Las características que debe cumplir para ser útil son:

Característica	Descripción
Brevedad	Debe ser de corta duración, ya que los profesionales generalmente no disponen de largos períodos de tiempo.
Sensibilidad	Debe ser lo suficientemente sensible para detectar la disfunción cognitiva sospechada, logrando un equilibrio entre la brevedad y la capacidad de detección.
Fácil Aplicación	Debe ser fácil de realizar y no requerir de un gran entrenamiento, permitiendo que sea aplicado por médicos generalistas, clínicos, enfermeros y agentes primarios de salud.
Materiales Mínimos	Idealmente, no debe requerir gran cantidad de materiales especializados (como cuadernillos u objetos), necesitando en el mejor de los casos solo lápiz y papel.
Aceptabilidad	Debe ser aceptable para la población anciana, que es la de mayor prevalencia de trastornos cognitivos.
Independencia de Factores Demográficos	Idealmente, no debe variar demasiado con respecto al sexo, la edad y los años de educación (aunque muchos tests están afectados por el nivel educacional).
Propiedades Psicométricas	Debe ser estandarizado, cuantificable, replicable, sensible y válido . También debe demostrar confiabilidad (resultados consistentes a lo largo del tiempo o entre examinadores).

Tests de Screening Cognitivo existentes

Existen diversas herramientas de rastreo breve (también llamadas pruebas de tamizaje) que son utilizadas en la práctica clínica:

1. Mini-Mental State Examination (MMSE): Es el test cognitivo abreviado de mayor validez y difusión internacional. Es muy breve, fácil de aplicar y de gran aceptación. Su debilidad radica en que su utilidad se restringe a los trastornos cognitivos severos, siendo poco sensible para detectar Deterioro Cognitivo Leve y por no evaluar abstracción ni funciones ejecutivas.

2. Short-Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ) o Cuestionario de Pfeiffer: Prueba muy breve (10 ítems) que evalúa orientación, memoria de evocación, concentración y cálculo.

3. Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE / ACE-R): Instrumento más sensible que el MMSE para detectar demencias y útil para discriminar entre Enfermedad de Alzheimer (EA) y Demencia Frontotemporal (DFT). Incorpora el MMSE y evalúa 6 dominios cognitivos (memoria, orientación, atención, fluencia fonológica/semántica, lenguaje y visuoespacialidad). También existe el **MINI ACE (M-ACE)**, una versión más corta y sensible que el MMSE.

4. Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Diseñado como un instrumento de escaneo rápido para alteraciones cognitivas leves. Evalúa atención, funciones ejecutivas, lenguaje, memoria, habilidades visuoconstructivas, pensamiento conceptual, cálculo y orientación. Existen versiones para baja educación (MoCA-B) y para personas con compromiso visual (MoCA-BLIND).

5. Mini-Cog: Instrumento muy rápido (3 minutos) que consta de dos pruebas: recuerdo de tres palabras (memoria/atención) y el dibujo de un reloj (función ejecutiva/visuoconstrucción). Su fácil y rápida administración permite detectar deterioro cognitivo durante visitas de rutina.

6. Alzheimer Disease Assessment Scale (ADAS): Diseñada para evaluar dominios cognitivos, perfiles de memoria y trastornos conductuales característicos en pacientes con EA. Es sensible al deterioro cognitivo más precozmente que el MMSE, pero requiere más tiempo y material especializado.

7. Escala de deterioro mental de Mattis (Mattis Dementia Rating Scale – MDRS o DRS): Instrumento más efectivo que el MMSE, utilizado en enfermedades demenciantes con compromisos cognitivos subcorticales. Evalúa 5 subescalas: Atención, Iniciativa/Perseveración, Construcción, Conceptualización y Memoria. Es útil para seguimiento de deterioro moderado a severo.

8. Frontal Assessment Battery (FAB): Herramienta rápida (menos de 10 minutos) útil en la evaluación de **funciones ejecutivas**. Es útil para el diagnóstico diferencial entre EA y DFT.

9. INECO Frontal Screening (IFS): Prueba de screening ejecutiva sensible y específica que incluye subtests de programación motora, instrucciones de conflicto, control inhibitorio, memoria de trabajo y pensamiento abstracto.

10. Tests específicos como el **Test del Reloj** (evalúa habilidades visuoconstructivas y praxias constructivas, además de múltiples funciones cognitivas), el **Trailmaking Test (TMT)** (evalúa habilidades motoras, visoespaciales, atención sostenida y flexibilidad mental), y las pruebas de **Fluencia Verbal** (evalúan flexibilidad mental, velocidad de procesamiento y lenguaje).

11. Prueba dirigida al cuidador: El **AD8** es un instrumento simple y breve de 8 preguntas que evalúa cambios en áreas comprometidas en la patología demencial, idealmente completado por el cuidador primario.